



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALĂ

Pacienta ANGHEL SABINA TEODORA, în vârstă de 6,6 ani, CNP: 6020703080114, domiciliată în jud. Brașov, loc. Brașov, str. Morii, nr. 12A, a fost internată în perioada: 13.01.2009-21.01.2009 cu **diagnosticul**:

1. INFECȚIE CRONICĂ A SNC CU CMV A.888
2. SY HIC BENIGN G.932
3. ESI CU PARAPAREZĂ FLASCĂ + SY CEREBELOS G.820+G.804
4. RETARD SEVER PSIHIC ȘI DE LIMBAJ F.801+F.729
5. RETARD SEVER NEURO-MOTOR F.82
6. MALFORMAȚIE SNC (SY DANDY WALKER) Q.031
7. PROLAPS DE VALVĂ MITRALĂ Q.238
8. INSUFICIENȚĂ MITRALĂ MEDIE Q.233
9. SUSPECT HIPOTIROIDISM Z.038
10. CONSILIERE Z.713+Z.718

ISTORICUL BOLII: Pacientă în vârstă de 6,6 ani, provenită dintr-o sarcină patologică (cu iminență de avort și cu cerclaj la 4 luni de sarcină, mama a prezentat o viroză respiratorie la 2 luni de sarcină și a fost tratată pe parcursul sarcinii pentru hipotiroidie cu 125mg Euthyrox / zi). Se internează pentru investigații și tratament complex de specialitate prezentând retard sever în dezvoltarea neuro-motorie, psihică și de limbaj, mers ataxic, dismetrie la membrele superioare, stigmatice genetice. Pacienta s-a născut la 8½ luni de sarcină, Gn= 1150g, Apgar 8; la vârsta de 3 săptămâni s-a intervenit chirurgical pentru persistență de canal arterial. Ulterior, dezvoltarea pe etape de vârstă a fost întârziată. Dintre antecedentele heredocolaterale menționăm un frate decedat la vârsta de 1 lună datorită unei malformații congenitale severe. În cursul consulturilor de specialitate anterioare. S-au solicitat și efectuat: IgM anti Rubeolă negativ, IgG anti Rubeolă negativ, IgM anti CMV negativ, IgG anti CMV echivoc; CPK în limite normale, excluzându-se distrofia musculară; dozarile hormonale (TSH, FT₄) au exclus hipotiroidia la copil; Rtg bazin: spina bifidă sacrală, displazie coxo-femurală bilaterală și coxa valga; CT cranian (07.12.2007): Hipoplazie de vermi cerebelar și emisfere cerebeloase. Cisterna magna mărită în volum ce comunică cu ventricolul IV. Chist arahnoidian temporal drept. Chist de Septum Pellucidum; RMN cranio-cerebral și de coloană vertebrală (ianuarie 2008): Modificări cu aspect sechelar supratentorial cu diminuarea substanței albe; subțierea corpului calos. Cisterna magna mărită de volum, prin hipoplazia emisferelor cerebeloase și a vermisului cerebelos, ce comunică larg cu ventricolul IV pe linia mediană. Coloana lombară cu aspect IRM normal; ecocardiografie (22.08.2005): Prolaps de valvă mitrală. Insuficiență mitrală gradul II/III. Până în ianuarie 2009 pacienta a urmat tratament medicamentos cu (Uteplex, Risatarum, Carnil, Sargenor, Straterra) + gimnastică medicală.

EX. CLINIC GENERAL: Starea generală: relativ bună; starea de nutriție: corespunzătoare; starea de conștiență: păstrată; facies: expresiv; tegumente: normal colorate; mucoase: normal colorate; fanere: corespunzătoare vârstei; țesut conjunctiv adipos: normal reprezentat; sistem ganglionar: nu se palpează ganglioni măriți patologic; sistem muscular: hipotonie musculară generalizată; sistem osteo-articular: integru, mobil; aparat respirator: relații normale; aparat cardiovascular: suflu sistolic la toate focarele de auscultație; aparat digestiv: abdomen suplu, elastic, sensibil în epigastriu; ficat, căi biliare, splină: relații normale; aparat urogenital: nu are control sfincterian.

EX. NEUROLOGIC: PC= 51cm; stigme genetice (boltă ogivală, hipertelorism și discret epicantus); hipotonie generalizată cu semnul fularului și proba călcâi-fesă pozitive; frust strabism convergent; forța segmentară redusă la membrele inferioare; ROT simetrice, fără reflexe patologice; prehensiunea bună bilateral, dar cu dismetrie; șade; se ridică în șezut; pășește fără sprijin, nesigur, cu baza largă și titubații; se ridică în ortostatism ținându-se de obiecte; parapareză flască+ sdr. cerebelos; nivel de dezvoltare aproximativ 1 an.

EX. PSIHIIC: cunoaște membrii familiei și se bucură la vederea lor; e veselă, prietenoasă, zâmbește la stimulare; se joacă cu jucăriile pentru timp scurt; mănâncă și singură; bea din cană cu ajutor; nu are educație sfincteriană; nu arată părțile corpului; nivel expresiv la nivel de 2 cuvinte bisilabice uneori cu sens, în rest lalalizează; privește unele obiecte cunoscute la solicitare; retard sever psihic și de limbaj; nivel de dezvoltare aproximativ 1 an.

ANALIZE: IgG pentru CMV 180,6IU/ml pozitiv, IgG pentru TOXO 0,1IU/ml negativ.

- examen de urină: relații normale; Urocultură: sterilă;

EEG: nr. 71/14.01.2009: Traseu teta fără asimetrie, fără anomalii, ceva mai hipovoltat în F-C drept. (Dr. Racoș)

RTG CRANIAN: nr. 21/ 17.01.2009: Craniu globulos cu tăblia subțiată în vertex și suturi ușor dehiscente spre vertex; impresiuni digitate occipital; hipertrofia apofizelor clinoid, cu tendință la punte supraselară. (Dr. Racoș)

EX FO: 95/20.01.2009/ Papile conturate , ușor mai palide temporal (Dr Popescu Ovidiu)

EX ENDOCRINOLOGIC: nr. 68/15.01.2009: Diagnostic: Sdr. malformativ, Hipotiroidie. Recomand: TSH, FT₄, ac ATPO; ex genetic + test Barr; Rtg de șa, mână, genunchi; echo abdominal (pentru depistarea altor malformații). (Dr. Năsălean)

EX CARDIOLOGIC: nr. 14/16.01.2009: Diagnostic: Prolaps de valvă mitrală anterior și posterior, Degenerescență mixomatăică valvă mitrală; Insuficiență mitrală medie; Canal arterial închis chirurgical; MCC operat ~~1994~~; Insuficiență mitrală gradul II/III. Local: zgomote cardiace ritmice bine bătute, ficat nepalpabil, puls periferic palpabil bilateral. EKG: fără semne de supraîncărcare. ECO: Pericard liber, tractabilitate globală bună, SIA intact, SIV intact, Degenerescență mixomatoasă valvă mitrală; Prolaps valvă mitrală anterioară și posterioară; Insuficiență mitrală medie (vena subtractă ≈ 3,6mm). Tratament + recomandare: profilaxia endocarditei bacteriene; reevaluare cardiologică peste 6 luni. (Dr. Muntean)

ECHO-ABDOMINAL: 16.01.2009: Ficat: ecostructură omogenă, ecogenitate de dimensiuni normale; Colecist: contractat postprandial; CBP, UP: calibru normal; Pancreas: ecostructură de dimensiuni normale; RD= 99/25,4mm, IP= 10,5mm, bună delimitare cortico-medulară, duplicarea ap. colector în observație, malrotație în observație fără dilatație pielocaliceale fără calculi; RS= 80/32mm, IP= 11mm, bună delimitare cortico-medulară, fără dilatații pielocaliceale, fără calculi; Splina: ecostructură, dimensiuni normale; Vezica urinară: cantitate mică de urină, conținut transonic, posibil imagine ureterool drept (ar fi nevoie de vezică urinară plină pentru confirmarea suspiciunii. Recomand consult nefrologie pediatrică, ex urină, urocultură. Revăzută Echografic: 20.01.2009/ Aspectul rinichilor același ca și la examinare anterioară , fără imagine de uretrocel. (Dr. Voicu)

CONSULT GENETIC. 19.01.2009/ -ESI cu parapareză flască.Retard sever neuromotor psihic și de limbaj.Srd. Dandy Walker .Prolaps de valvă mitrală.Degenerescență mixomatăică valvă mitrală.Discret epicantus;- s-a recoltat ptr. Test Barr - la rec. Dr.Năsălean. Rec: dispensarizare neuropsihiatrică și cardiologică;- control gențic când vine la cardiologie. (Dr Bănescu)

LAB. GENETICĂ UMANĂ: 3./19.01.2009/ CROMATIMA SEXUALĂ : Test Barr = pozitiv (13 %)

EX. PEDIATRIC: 20.01.2009/ Elucidarea dg. de Malformație renală necesită internare la Cl. Pediatrie .Rec. tratament antibiotic dacă are I.T.U. (conform antibiogramei) Prof. Conf. Dr Kiss Eva

EXAMEN PSIHOLOGIC. 19.01.2009/ Dezvoltare psihică și de limbaj: - vârsta de percepție : 9-10 luni;- vârsta de îndemănare: 10-11 luni,- vârsta socială: 8-9 luni ; - vârsta de

independență: 10-11 luni;- vorbire activă 9-10 luni.Retard sever în dezvoltarea psihică și de limbaj. (Psiholog Lukacs Agota)

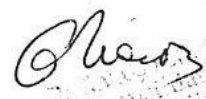
A urmat tratament cu Spironolactonă, Acyclovir, Cerebrolysin, Vit B12 și Fenobarbital de protecție, Tanakan, Vit B6, CFM+ EFT cu evoluție favorabilă, externându-se în stare gen. bună, ameliorată neuro-motor, vîioaie, mai atentă, cu următorul: **PLAN DE RECUPERARE:**

1. Tratament cronic cu : Spironolactonă 25 mg. 1/4-0-0 tb ;- va primi cîte 10 zile pe lună Acyclovir. 200 mg : 3x1/2 tb și Sargenor : 1 f. po, urmat de Tanakan : 1-1-0 ml și Carnil 1,0 g 2x1/2 flac/zi alternativ cu Encephabol sirop: 1-1-0 l-ță 20 zile pe lună , apoi va face Cerebrolysin 2 ml +Vit B12 50 γ 1 f. im 10 zile (sub protecție de Fenobarbital 100 mg: 1/8 - 0 - 1/4 tb)
2. Continuarea gimnasticii medicale și a stimulării psihice în familie.
3. Integrare în colectivitatea ptr. copii cu nevoi speciale .
4. Control prin LSM teritorial .
5. Reinternare la Cl. NPP Tg-Mureș peste 4-5 luni ptr. continuarea tratamentului complex de recuperare.
6. Control endocrinologic cu rezultatele dozărilor hormonale recomandate (TSH, FT4 ,atc. ATPO).
7. Pentru internare este obligatorie aducerea Certificatului de naștere a copilului, copie xerox, a Carnetului albastru de asigurat a copilului dacă există, iar pentru mamele care se internează, a Buletinului de identitate, Carnetului albastru de asigurat sau adeverința de la locul de muncă al tatălui, pentru mamele casnice. Pentru copiii cu grad de handicap este obligatorie aducerea Hotărârii (copie xerox) pe anul în curs, cât și dovada angajării mamei ca asistent personal, acolo unde este cazul. De asemenea se va aduce Bilet de recomandare pentru internare de la medicul de familie sau un medic specialist. Ne rezervăm dreptul să refuzăm internarea, dacă lipsesc datele sus menționate.
8. Va veni cu analize de laborator făcute, fie în policlinică, fie la un laborator particular în jud. Mureș, respective în jud. de domiciliu. Lista analizelor necesare va fi eliberată de medicul curant. (*hemoleucograma, ex. urine, ex. scaune*)
9. În caz de intercurență se va reprograma la telefon 0265/264388 (secretară Mureșan Adina)

MEDIC ȘEF DE SECȚIE
PROF. UNIV. ASOC.
DR. VOICA FOIȘOREANU


PROF. UNIV.
Dr. VOICA FOIȘOREANU
medic primar - neurologie
și psihiatrie pediatrică
doctor în științe medicale
Cod: 621397

MEDIC DE SALON
MEDIC PRIMAR
DR. SZABO RACOS ELISABETA


SECRETARĂ MUREȘAN ADINA